

認識心肌梗塞

血管突然被血栓塞住，心肌正在壞死——每一分鐘都算數
看懂症狀、知道要打 119、了解治療與復健



掃描看電子版

什麼是心肌梗塞？有什麼症狀？

斑塊破裂 → 血栓塞住 → 心肌開始壞死



典型症狀——持續超過 5 分鐘不會自己好



胸口壓迫



冒冷汗



喘不過氣



噁心想吐



痛會轉移



快要昏倒

特別注意：女性、長輩、糖尿病人常不會胸痛，可能只覺得喘、累、噁心或上腹悶，容易被當成胃病而延誤。

誰的風險高？

紅 = 可以改變 灰 = 不能改變，但更要控制其他項目



抽菸



高血壓



高血脂



糖尿病



肥胖少動



家族史



年齡與性別

有多危險？

時間就是心肌——越晚打通，壞死越多、心臟功能掉越多

前幾小時

最危險的時段
可能突發致命心律不整

90 分鐘

到院後打通血管的目標
台灣的照護品質指標

不要自己開車

路上失去意識會更糟
救護車上就能做心電圖

醫師會怎麼治療？

首選是緊急心導管，把塞住的血管盡快打通

緊急心導管（主要做法）

從手腕或鼠蹊部放入導管，找到塞住的地方
抽出血栓，以氣球撐開，多數會放支架固定
健保全額給付傳統支架；塗藥支架需自付差額

出院後的藥一定要吃

兩種抗血小板藥至少吃滿一年，自行停藥
可能造成支架內急性血栓，後果嚴重
另有降血脂等長期用藥；乙型阻斷劑依心臟功能決定

什麼時候能回到原本的生活？

以下為一般情況，實際請由醫師依您的心臟功能決定

走路

出院後就開始

開車

約 1~2 週

性生活

約 3 週

回去上班

多數 1~3 個月

努力工作

需個別評估

職業駕駛另有規定；裝有去顫器或心臟功能較差者，上述時間都會不同。

心臟復健：不是多休息，是要動起來

可降低再梗塞與死亡率

第一期 住院中

下床、走動，減少臥床併發症

第二期 出院後

醫院監測下的運動訓練，健保有療程

第三期 長期

把運動變成生活習慣，自己維持

！ 出現這些情況，立刻打 119

胸口壓迫或悶痛超過 5 分鐘不緩解 · 含了硝化甘油仍沒有改善 · 冒冷汗、喘不過氣、快要昏倒
不要自己開車、不要等家人載——救護車上就能做心電圖並事先通知醫院準備，比你自己到院快得多。